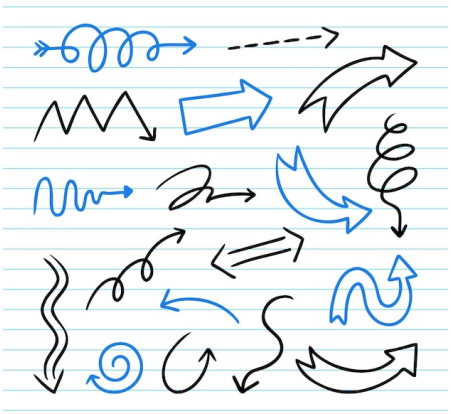


TEMA 23



ESQUEMA DEL TEMA

LEY 12/2.022, DE 21 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

REFERENTES LEGISLATIVOS DE LA LEY DE SS.SS. (PREÁMBULO)	
REFERENTES INTERNACIONALES.	. Declaración Universal DD.HH. de 1.948. . Carta Social Europea de 1.961. . Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de DD.HH. de 1.993. . Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (2.000). . Pilar Europeo de Derechos Sociales de 2.017.
CONSTITUCIÓN.	. Art. 9.2. . Art. 10.

ESTRUCTURA DE LA LEY.
- **113 artículos.** - **1 Título Preliminar.** - **8 Títulos.** - **3 disposiciones adicionales.** - **6 disposiciones transitorias.** - **1 disposición derogatoria.** - **2 disposiciones finales.**

TÍTULO PRELIMINAR.	**DISPOSICIONES GENERALES.**
TÍTULO I. EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	
Capítulo I.	**Concepto, contenido y principios rectores.**
Capítulo II.	**Competencias de las Administraciones Públicas.**
Capítulo III.	**Organización funcional.**
Capítulo IV.	**Organización territorial.**
TÍTULO II. PRESTACIONES DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.	
Capítulo I.	**Naturaleza, clases y garantía jurídica de las prestaciones.**
Capítulo II.	**Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales.**
TÍTULO III. PROFESIONALES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, REGISTROS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.	
Capítulo I.	**Profesionales de los servicios sociales.**
Capítulo II.	**Sistema de información y registros.** - **Sección 1ª. Sistema de información.** - **Sección 2ª. Registros.**
Capítulo III.	**Instrumentos técnicos de los servicios sociales.**
TÍTULO IV. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES, ORDENACIÓN Y PARTICIPACIÓN.	
Capítulo I.	**Planificación de los servicios sociales.**
Capítulo II.	**Centros y servicios de atención social.**
Capítulo III.	**Ordenación de la actividad de los centros y servicios de atención social.**
Capítulo IV.	**Participación.**
TÍTULO V. PROVISÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES.	
Capítulo I.	**Formas de provisión.**
Capítulo II.	**Concierto social.**
TÍTULO VI. CALIDAD, TRANSPARENCIA, INSPECCIÓN Y FORMACIÓN.	
Capítulo I.	**Calidad, evaluación y transparencia de los servicios sociales.** - **Sección 1ª. Calidad y evaluación.** - **Sección 2ª. Transparencia.**
Capítulo II.	**Función inspectora.**
Capítulo III.	**Innovación y formación en servicios sociales.**

TÍTULO VII. FINANCIACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.	
TÍTULO VIII. RÉGIMEN SANCIONADOR.	
Capítulo I.	**Infracciones.** - **Sección 1ª. Disposiciones generales.** - **Sección 2ª. Infracciones en el ejercicio de la actividad de centros y servicios de atención social.** - **Sección 3ª. Infracciones de los usuarios de centros y servicios y beneficiarios de las prestaciones.**
Capítulo II.	**Sanciones.** - **Sección 1ª. Sanciones en el ejercicio de la actividad de centros y servicios y a los usuarios de centros y servicios y a los beneficiarios de las prestaciones.** - **Sección 2ª. Disposiciones generales.**
Capítulo III.	**Procedimiento sancionador.**

TÍTULO PRELIMINAR.	
Art. 1. **Objeto.**	Configurar el marco jurídico de los SS.SS. en la CM: 1.- Garantizar los derechos subjetivos → Sistema público universal → Promoción de la autonomía personal, convivencia familiar, inclusión social, desarrollo comunitario y calidad de vida en todas las etapas. 2.- Regular y ordenar el conjunto de prestaciones del Sistema Público de SS.SS. (SPSS) / la actividad de entidades, centros y servicios / las actuaciones de inspección y control de la calidad. 3.- Prestación de SS.SS. em condiciones de calidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos, la prevención, la detección precoz, la atención, la protección y la reparación del daño.
Art. 2. **Ámbito de aplicación.**	1.- SS.SS. que prestan las Administraciones Públicas (AA.PP.) / SS.SS. de las entidades públicas vinculadas o dependientes / SS.SS. de las entidades privadas colaboradoras con o sin ánimo de lucro. 2.- SS.SS. prestados por entidades privadas no incluidos en el SPSS → se les aplica la normativa referida a: a.- Derechos y deberes de los usuarios y profesionales. b.- Registro de Entidades, Centros y Servicios / Registro de Directores de Centros / Registro Único de Usuarios. c.- Ordenación de la actividad de centros y servicios. d.- Función inspectora y régimen sancionador.
Art. 3. **Derecho subjetivo de acceso.**	El acceso a las prestaciones del SPSS se configura como derecho subjetivo de acuerdo con los requisitos establecidos, su desarrollo reglamentario y normativa en vigor.
Art. 4. **Titulares.**	1.- Son titulares del derecho de acceso a las prestaciones del SPSS: a.- Personas con vecindad administrativa en la CM. b.- Españoles en el exterior cuya última vecindad fuera en la CM. c.- Personas refugiadas o con derecho a la protección subsidiaria. d.- Menores de edad que se encuentren en la CM. e.- Personas en situación de urgencia/emergencia social → Servicios de información, valoración y orientación en la atención social primaria (ASP). 2.- El acceso se realizará según lo establecido en el Catálogo de Prestaciones de SS.SS. y la Cartera de Servicios de la CM.
Art. 5. **Derechos de los usuarios.**	1.- Toda persona que accede al SPSS tiene derecho a: a.- Recibir información suficiente y veraz sobre las prestaciones, derechos públicos subjetivos y requisitos de acceso. b.- Ser atendido de forma individualizada, respetando la dignidad personal, mutua consideración, tolerancia y colaboración / Profesional de referencia que asegure la coherencia y globalidad del proceso de atención y la libre elección. c.- Valoración inicial → Plan individualizado de intervención → Autonomía, inclusión social y calidad de vida / coordinación con sistema sanitario, educativo, de empleo, de vivienda. d.- Participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención social. e.- Recibir el apoyo necesario en el ejercicio de su capacidad jurídica.

	f.- Disponer de una Historia Social Única accesible de forma universal para prestar una atención personalizada e integral. g.- Confidencialidad respecto a la información conocida y protección de los datos personales. h.- Acceder y cesar voluntariamente en la utilización de la prestación / mantener la continuidad / En ningún caso se podrá establecer un ingreso en un centro sin la voluntad del usuario. i.- Acceder a los cauces de información, sugerencia y queja. j.- Participar en los órganos de representación del SPSS y en órganos de la iniciativa privada. k.- Recibir la información necesaria para el cumplimiento de las funciones de participación. l.- Obtener respuestas de las AA.PP. en el plazo legalmente establecido. 2.- En relación con la atención en los centros y servicios de atención social del SPSS: a.- Acceder en condiciones de igualdad y no discriminación. b.- Obtener un programa de intervención individual realizado con la participación y conocimiento del usuario. c.- Preservar la intimidad personal y familiar. d.- Mantener relaciones interpersonales / derecho a recibir visitas. e.- Participar en las actividades. f.- Conocer el reglamento de régimen interior. g.- Ingresar, permanecer y salir libremente del centro con respeto a las normas de convivencia y funcionamiento establecidas. h.- No ser sometidas a restricción física o tratamiento farmacológico sin prescripción facultativa. 3.- La relación de derechos debe exponerse en lugar visible en centros y servicios.
Art. 6. **Deberes de los usuarios.**	Toda persona que accede a los SS.SS. tiene los siguientes deberes: a.- Facilitar información veraz sobre circunstancias personales, familiares, sociales y económicas / comunicar a la Administración cualquier variación en las mismas. b.- Respetar la dignidad y derechos del resto de usuarios y profesionales → mutuo respeto, tolerancia y colaboración. c.- Cumplir las normas, requisitos y procedimientos. d.- Acudir a las entrevistas / participar de manera activa en las iniciativas orientadas a la autonomía personal, prevención de la dependencia, inserción social y mejora de la calidad de vida. e.- Destinar las prestaciones recibidas a la finalidad para la que se conceden. f.- Utilizar y cuidar de forma responsable las instalaciones de centros y servicios. g.- Contribuir a la financiación del coste del servicio, según la capacidad económica del usuario.

TÍTULO I. EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.	
Capítulo I. Concepto, contenido y principios rectores.	
Art. 7. **Sistema Público de SS.SS.**	1.- El SPSS es un servicio público universal → red integrada de recursos, programas, prestaciones y equipamientos de atención social / responsabilidad y control público / ejercidos por las Administraciones autonómica y local. 2.- Función: asegurar a las personas el derecho a vivir dignamente todas las etapas de la vida. 3.- Finalidad: favorecer la integración social / la igualdad de oportunidades / la autonomía personal / la convivencia familiar / la participación social / el bienestar social de todas las personas, familias y grupos → Función promotora, preventiva, protectora y de atención frente las necesidades sociales. 4.- Reserva de utilización de expresiones: Sistema Público de Servicios Sociales, Red de Servicios Sociales, Red de Atención Social Primaria, Centro de SS.SS., Centro de Atención Social.
Art. 8. **Principios rectores del SPSS.**	1.- Principios del SPSS: universalidad, igualdad, equidad, no discriminación, singularidad y solidaridad / responsabilidad pública e institucional, calidad, planificación y evaluación, eficacia y eficiencia social, concurrencia y coordinación, accesibilidad universal, interdisciplinariedad, atención centrada en la persona, proximidad, impulso digital, innovación, trabajo en red y promoción de la iniciativa social y del voluntariado. 2.- Principios de la intervención social: prevención, autonomía del usuario y desarrollo personal, integración familiar y social, proporcionalidad y necesidad, atención individualizada, integral y continuada, equidad territorial, proximidad, enfoque comunitario y participación.
Capítulo II. Competencias de las Administraciones Públicas.	
Art. 9. **Disposición general.**	Las competencias en SS.SS. corresponden a la Comunidad de Madrid y a las entidades locales.
Art. 10. **Competencias Adm. CM.**	1.- Planificación y desarrollo de una política de SS.SS. y atención social: a.- Diseño de criterios generales y modelos de intervención para la ASP y especializada. b.- Cooperación para el desarrollo de la ASP → financiación de la red básica de SS.SS. c.- Elaboración y aprobación del Plan Director de SS.SS. d.- Elaboración y aplicación del Catálogo de Prestaciones y la Cartera de Servicios. e.- Elaboración y aprobación del Mapa de SS.SS. f.- Elaboración y aprobación de los instrumentos técnicos: Historia Social Única y Tarjeta Social. 2.- Provisión y prestación de los servicios de atención especializada. 3.- Planificación y atención, en colaboración con las entidades locales, en situaciones de urgencia y emergencia social. → Emergencia social: accidentes, estragos … que causan grave daño a la población, pueden producir estados de vulnerabilidad y desprotección sobrevenidas e inesperadas a grupos de personas. → Urgencia social: situación excepcional o extraordinaria o de agravamiento de las circunstancias personales o familiares → Respuesta inmediata del SPSS.

	4.- Aseguramiento de la suficiencia financiera, técnica y de recursos humanos. 5.- Determinación de precios públicos de referencia para la prestación de servicios. 6.- Creación, regulación y mantenimiento de los registros. 7.- Potestad inspectora, de control de la calidad y sancionadora. 8.- Fomento de la participación ciudadana, asociacionismo, voluntariado y de ayuda mutua. 9.- Promoción de procedimientos para la resolución de conflictos.
Art. 11. **Competencias Entidades Locales.**	1.- Competencias de los municipios, por solos o integrados en mancomunidades: a.- Desarrollo de las funciones de ASP. b.- Planificación de los SS.SS. en su ámbito territorial. c.- Establecimiento, mantenimiento y gestión de centros y servicios, dotación de personal suficiente y adecuado de ASP. d.- Gestión de equipamientos para la atención social especializada de titularidad municipal. e.- Concesión de prestaciones económicas individuales de urgencia y emergencia social y de ayudas económicas temporales. f.- Apoyo a las entidades del Tercer Sector. g.- Programas de sensibilización social, fomento de la participación ciudadana, promoción del asociacionismo, voluntariado … h.- Creación e impulso de los consejos locales de SS.SS. i.- Colaboración en las funciones de inspección y control de la calidad. j.- Coordinación con las entidades con o sin ánimo de lucro. k.- Competencias atribuidas a la Administración local en la normativa sectorial. 2.- Estas competencias las ejercerán los municipios, por sí mismos o asociados. 3.- Los municipios pueden establecer recursos de atención social especializada de titularidad municipal. 4.- La propuesta será estudiada por la CM (6 meses). 5.- Las entidades locales deben usar las herramientas técnicas establecidas.
Art. 12. **Colaboración,** **Cooperación y coordinación.**	1.- Las AA.PP. deben colaborar y cooperar entre sí. 2.- Coordinación con otros sistemas públicos de protección social → salud, pensiones, empleo, educación, igualdad, vivienda y justicia → Protocolos de derivación. 3.- Colaboración con la Administración del Estado y con el resto de CC.AA. 4.- Implantación de sistemas interoperables de acceso a la Historia Social Única e integración de la Tarjeta Social. 5.- Colaboración con la iniciativa privada.
Capítulo III. Organización funcional.	
Art. 13. **Organización funcional del SPSS.**	1.- El SPSS se organiza en dos niveles de atención: Atención Social Primaria y Atención Social Especializada. 2.- Complementariedad y acción coordinada entre los niveles → continuidad de la intervención a través de itinerarios específicos de cada persona, familia, grupo y comunidad.

Art. 14. **Atención Social Primaria.**	1.- ASP: vía normalizada de acceso al SPSS / Carácter polivalente / Atención social individualizada, específica, cercana y en el propio entorno de la persona. 2.- Equipamiento básico de la ASP → Centro de SS.SS., dependiente de las entidades locales → Red de ASP de la CM. 3.- Establecimiento de los centros con criterios de población, necesidad y oportunidad. 4.- Los Centros de SS.SS. de ASP serán de titularidad pública.
Art. 15. **Funciones de la ASP.**	Funciones de la ASP: 1.- Recepción, detección y análisis de necesidades y demandas sociales. 2.- Diagnóstico y valoración técnica de situaciones, necesidades o problemas individuales o colectivos. 3.- Identificación de situaciones y ámbitos sociales de riesgo. 4.- Atención inmediata a personas en riesgo o exclusión social. 5.- Atención profesional personalizada en los ámbitos personal, familiar y comunitario → información, valoración y acompañamiento / seguimiento y coordinación. 6.- Actuación en situaciones de urgencia y emergencia social. 7.- Gestión y seguimiento de prestaciones económicas y servicios de acompañamiento. 8.- Fomento de la participación, solidaridad y cooperación social. 9.- Emisión de informes sociales. 10.- Proyectos de intervención en los ámbitos grupal y comunitario. 11.- Coordinación con la atención social especializada y otros sistemas y servicios.
Art. 16. **Profesional de referencia.**	1.- El Centro de SS.SS. designará un profesional de referencia → dar coherencia al itinerario de intervenciones / garantizar el acceso a los servicios y prestaciones. 2.- En la ASP será el trabajador social → realización de valoración y diagnóstico / propuesta de las prestaciones al equipo interdisciplinar. 3.- Responsable del seguimiento del plan personalizado y de la atención social, así como de la Historia Social Única.
Art. 17. **Equipos profesionales.**	Elemento central de intervención del SPSS → llevar a cabo y procurar el acceso a las medidas de apoyo y que requiere cada persona, familia o grupo.
Art. 18. **Atención Social Especializada.**	1.- Atención Social Especializada (ASE) → atención a las necesidades singulares de personas o grupos → programación, implantación y desarrollo de acciones que requieren recursos materiales, técnicos y profesionales. 2.- Actuaciones y equipamientos para la atención especifica de personas o grupos. 3.- Acceso a través de los profesionales de ASP. 4.- Red Especializada de SS.SS.: prestaciones, servicios y equipamientos residenciales y no residenciales destinados a un mismo sector de atención.
Art. 19. **Funciones de la ASE.**	Funciones de la ASE: 1.- Valorar, diagnosticar y orientar a personas, familias o grupos. 2.- Proporcionar prestaciones de servicio o económicas a personas con dificultades físicas, psíquicas o sociales → Inclusión social, prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal → Actuación preferente en el entorno o en centros residenciales.

Capítulo IV. Organización territorial.	
Art. 20. **Previsión general.**	Distribución territorial equilibrada de los Servicios de ASP y ASE → Accesibilidad universal a los servicios y recursos → Cobertura homogénea y adaptada a las necesidades reales.
Art. 21. **Divisiones territoriales.**	El Consejo de Gobierno establecerá la división territorial atendiendo a criterios demográficos, de accesibilidad, proximidad y de coordinación con otros sistemas públicos.
TÍTULO II. PRESTACIONES DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.	
Capítulo I. Naturaleza, clases y garantía jurídica de las prestaciones.	
Art. 22. **Naturaleza de las prestaciones y condiciones de acceso.**	1.- Las prestaciones del SPSS tienen carácter universal y son accesibles en los términos previstos en la normativa específica. 2.- Están orientadas a fomentar la autonomía, prevenir la dependencia, promocionar la convivencia y protección de la infancia, la inserción social y la calidad de vida de personas, familias y grupos. 3.- Se clasifican: - Por su naturaleza → garantizadas y condicionadas. - Por su contenido → prestaciones de servicio y económicas. 4.- Las prestaciones se pueden combinar entre sí. 5.- El reconocimiento de las prestaciones se determinan por el profesional de referencia y los equipos profesionales. 6.- La concesión y el mantenimiento de las prestaciones se puede condicionar a la colaboración activa de los usuarios o su participación en la financiación.
Art. 23. **Prestaciones garantizadas y condicionadas.**	1.- Prestaciones garantizadas: se reconocen en la Ley de SS.SS. o en leyes de carácter sectorial. 2.- Derecho subjetivo del usuario en los términos y requisitos establecidos → Provisión adecuada y suficiente en los Presupuestos Generales de la CM. 3.- Prestaciones condicionadas → Se conceden en función de la disponibilidad de recursos y los criterios de prioridad establecidos.
Art. 24. **Prestaciones de servicio y económicas.**	1.- Prestaciones de servicio → Actuaciones profesionales temporales o permanentes → Prevención, rehabilitación social, habilitación funcional, diagnóstico, atención y apoyo en situaciones de necesidad social → Prevenir la dependencia, promover la autonomía e inclusión social → atención sociosanitaria, residencial y de día, ayudas instrumentales y asistencia tecnológica. 2.- Las prestaciones de servicio pueden ser gratuitas o con aportación del usuario. 3.- Prestaciones económicas → aportaciones dinerarias / periódicas o de pago único / mejorar las condiciones de vida dirigidas a personas o familias en necesidad personal o social.
Capítulo II. Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales.	
Art. 25. **Disposiciones generales.**	1.- Catálogo de Prestaciones de SS.SS. → Instrumento que determina el conjunto de prestaciones del SPSS → Determina su marco y asegura estándares de calidad y homogeneidad. - Se actualiza o modifica mediante norma con rango de Ley.

	2.- Cartera de Servicios → Instrumento vinculado al Catálogo de Prestaciones → Regulación del contenido y alcance de las prestaciones. - Será aprobada por la Consejería competente mediante orden de su titular. 3.- Contenidos de la Cartera de Servicios: a.- Servicios → características, modalidades y objetivos / necesidades a las que se dirige / derechos y obligaciones de los beneficiarios / estándares de calidad / requisitos y procedimientos de acceso y concesión / criterios de priorización. b.- Prestaciones económicas → Definición, objetivos, importe, periodicidad, condiciones, requisitos y procedimientos / derechos y obligaciones de los beneficiarios, estándares de calidad, causas de pérdida o extinción, reintegro de cantidades indebidamente percibidas. 4.- Coherencia entre el Catálogo de Prestaciones / Cartera de Servicios / Mapa de SS.SS.
Art. 26. **Prestaciones de servicio garantizadas y condicionadas.**	1.- Prestaciones de servicio garantizadas: a.- Servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento. b.- Elaboración del plan individualizado de intervención social / participación y aceptación de los usuarios → inclusión personal, social, educativa y laboral / promoción de la autonomía. c.- Atención inmediata en situaciones de urgencia o emergencia social. d.- Protección social y jurídica de niños em riesgo / desamparo / conflicto social. e.- Reconocimiento y acreditación de familias numerosas y familias monoparentales. f.- Seguimiento y supervisión de adopciones. g.- Puntos de encuentro familiar. h.- Servicio de apoyo a personas adultas para el ejercicio de su capacidad jurídica. i.- Protección a víctimas / unidad de convivencia de víctimas de violencia de género o trata. j.- Reconocimiento de las situaciones de discapacidad o dependencia. k.- Atención temprana a niños de 0 a 6 años → prevención, detección precoz y diagnóstico. l.- Mediación familiar y comunitaria. m.- Atención o intervención familiar o de la unidad de convivencia. n.- Apoyo psicosocial y atención psicoeducativa de la infancia y la familia. ñ.- Acompañamiento psicosocial para la integración de personas adultas con discapacidad o vulnerabilidad derivada de la enfermedad mental. 2.- Prestaciones de servicio condicionadas: a.- Alojamiento alternativo. b.- Atención diurna o ambulatoria. c.- Atención residencial.
Art. 27. **Prestaciones económicas garantizadas y condicionadas.**	1.- Prestaciones económicas garantizadas: a.- Renta Mínima de Inserción. b.- Prestaciones para la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia. c.- Compensación a personas acogedoras de menores de edad bajo guarda o tutela. d.- Ayudas económicas de pago único para mujeres víctimas de violencia de género.

	2.- Prestaciones económicas condicionadas: a.- Apoyo para la cobertura de las necesidades básicas, de manera temporal, en situaciones de urgencia o emergencia social. b.- Rehabilitación y accesibilidad universal de viviendas.
Art. 28. **Evaluación de resultados y actualización del Catálogo de Prestaciones y la Cartera de Servicios.**	1.- La Consejería determinará los objetivos específicos de calidad, indicadores y metodología → Plan de calidad de los SS.SS. 2.- Indicadores → garantía de derechos, mejora del bienestar/autonomía/calidad de vida, satisfacción con la atención recibida, igualdad entre mujeres y hombres, accesibilidad universal, calidad del empleo, eficiencia, cohesión social y territorialidad, sostenibilidad del SPSS. 3.- Análisis comparativo entre las prestaciones y servicios del SPSS. 4.- Evaluación de resultados cada 4 años con actualización anual de los datos. 5.- Se incluirán en la Cartera de Servicios las prestaciones garantizadas. 6.- Se podrán aprobar mediante orden del titular de la Consejería las modificaciones no sustanciales.
Art. 29. **Catálogos de prestaciones de SS.SS. del ámbito local.**	1.- Las entidades locales podrán aprobar sus propios catálogos de prestaciones de SS.SS. 2.- Las entidades locales comunicarán sus prestaciones a la Comunidad Autónoma.

TÍTULO III. PROFESIONALES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, REGISTROS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.	
Capítulo I. Profesionales de los Servicios Sociales.	
Art. 30. **Derechos de los profesionales.**	1.- Derechos de los profesionales de los SS.SS.: a.- Obtener la información necesaria para el ejercicio de sus funciones. b.- Participar en el proceso de toma de decisiones relativas a la atención social con criterios técnicos y profesionales. c.- Recibir un trato respetuoso, no discriminatorio y correcto por los responsables de los servicios, el resto de los profesionales y los usuarios. d.- Respeto del cumplimiento y ejercicio de sus derechos laborales, condiciones para el adecuado desempeño de las funciones profesionales, conciliación de la vida laboral y personal, desarrollo profesional. e.- Preservación de su intimidad e integridad personal / independencia profesional. f.- Abstenerse de practicar actos profesionales contrarios a sus convicciones morales (objeción de conciencia). g.- Formación continuada, adecuada y especializada a lo largo de su carrera profesional. 2.- Son profesionales de SS.SS. → los empleados públicos de las AA.PP. y de sus entidades vinculadas o dependientes / trabajadores de las entidades privadas.
Art. 31. **Deberes de los profesionales.**	2.- Deberes de los profesionales de los SS.SS.: a.- Comportamiento basado en el respeto mutuo y la no discriminación / normas de convivencia en los centros y servicios. b.- Conocer y cumplir la normativa vigente. c.- Desempeñar las funciones según las normas éticas y deontológicas → Humanización de la atención social. d.- Asistir y aprovechar diligentemente la formación y apoyo técnico. e.- Utilizar los medios técnicos para la mejor atención de las personas. f.- Guardar secreto sobre la Historia Social Única / respeto a las normas de protección de datos.
Art. 32. **Ratios de personal.**	1.- Personal suficiente → criterios de eficiencia, sostenibilidad, flexibilidad y adecuación a las necesidades de las personas atendidas → formación, titulación, conocimientos, capacidades y estabilidad laboral. 2.- Se establecerá reglamentariamente la estructura básica de referencia de los equipos profesionales y los ratios mínimos de referencia.
Art. 33. **Capacidades profesionales.**	Desarrollo de un modelo de gestión de las capacidades profesionales adecuado a las necesidades.
Capítulo II. Sistema de información y registros.	
Sección 1ª. Sistema de información.	
Art. 34. **Sistema de Información de SS.SS.**	1.- Sistema de información (SISS) del SPSS → Datos de las redes de ASP y ASE + Historias Sociales Únicas + Datos de gestión de las prestaciones. 2.- Objetivos del SISS: a.- Orientar y homogeneizar la acción profesional.

	b.- Integrar toda la información sobre una persona y su unidad familiar. c.- Facilitar la continuidad y complementariedad del proceso de atención. d.- Mejorar la eficacia de los procesos de intervención social. e.- Facilitar la coordinación y cooperación entre los diferentes sistemas de protección. 3.- Se arbitrarán los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar la protección de datos de carácter personal. 4.- Interoperabilidad con otros sistemas de protección y de atención. 5.- El SISS es desarrollado desde el órgano con responsabilidad en materia de informática de la CM. 6.- La incorporación al SISS es obligatoria para: todas las entidades del SPSS + entidades que reciben fondos públicos.
Art. 35. **Bases jurídicas tratamiento de datos personales.**	1.- Cumplimiento de la normativa vigente sobre tratamiento y protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 2.- Fines del tratamiento de datos personales del SISS: a.- Gestión de prestaciones del SPSS. b.- Actuaciones de las entidades públicas/entidades de iniciativa social/entidades privadas autorizadas → en protección de menores, atención a familias, a personas con discapacidad, a personas en dependencia, mayores, personas en vulnerabilidad o exclusión, personas que precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. 3.- El intercambio de datos personales obliga en todo caso a: a.- Entidades gestoras de servicios, recursos y prestaciones del SPSS. b.- Órganos, entidades y organismos de titularidad pública de otros sistemas de protección social, c.- Entidades, de titularidad pública o privada, prestadoras de servicios y recursos o que desarrollen programas subvencionados por las AA.PP., no integrados en el SPSS, que desarrollen actuaciones complementarias. 4.- Esta información podrá ser compartida con otros departamentos y otras AA.PP. cumpliendo los criterios de normalización, interoperabilidad, seguridad y privacidad, 5.- Los datos personales relativos a los usuarios de los SS.SS. se conservarán mientras mantengan su condición de usuarios y durante el tiempo necesario para cumplir los fines para los que fueron recabados.
Art. 36. **Acceso a la información en el SISS.**	1.- El acceso a la información del SISS cumplirá la normativa e materia de protección de datos de carácter personal. 2.- Tendrán acceso las personas que presten servicios en las entidades recogidas en el art. 35.3 para el ejercicio de su contenido profesional concreto y predeterminado, de interés público y en los términos establecidos → Se establecerán perfiles de acceso limitados. 3.- El acceso de los profesionales está sujeto a los deberes de secreto profesional y confidencialidad. 4.- El acceso a datos personales con fines estadísticos, de investigación o docencia se regirá por la legislación en materia de protección de datos.
Sección 2ª. Registros.	
Art. 37. **Registro de entidades, centros,**	1.- Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atención Social → En la Consejería competente en SS.SS. / carácter público / información relativa a entidades, centros y servicios.

servicios y directores.	2.- La inscripción en el Registro es a efectos de publicidad de las entidades públicas o privadas y de los centros de SS.SS. / Comunicaciones, autorizaciones y acreditaciones otorgadas / Conciertos sociales formalizados. 3.- Las inscripciones se mantendrán actualizadas. 4.- Registro de personas habilitadas para la dirección de centros de atención social.
Art. 38. **Registro único de usuarios.**	1.- Registro Único de Usuarios / Carácter no público / Adscrito a la Consejería competente en SS.SS. → Datos relativos a los usuarios de SS.SS. 2.- Se establecerán reglamentariamente sus características y régimen de funcionamiento. 3.- Se observará la normativa de protección de datos de carácter personal.
Capítulo III. Instrumentos técnicos de los Servicios Sociales.	
Art. 39. **Tarjeta Social.**	1.- Tarjeta Social: instrumento técnico de gestión y acceso a los servicios de carácter digital / Será determinada reglamentariamente por la Consejería. 2.- Tienen derecho todas las personas residentes en la CM → Las identifica en el marco del SPSS / Da acceso al SPSS / Recoge las prestaciones que perciben. 3.- Es personal e intransferible → facilita la continuidad y coherencia en la atención. 4.- La carencia de Tarjeta no impide la atención social de emergencia. 5.- Compatibilidad con otros instrumentos análogos → Integración de la tarjeta social y la tarjeta sanitaria para las personas en dependencia y con discapacidad.
Art. 40. **Plan individualizado de intervención social.**	1.- Toda personas, familia o unidad de convivencia dispondrán de un plan de intervención singularizado → Abordaje integral de la situación. 2.- Es un instrumento de intervención social / Participación de los usuarios → Será propuesto al equipo profesional por el profesional de referencia → Plazo máximo para su aprobación: 10 días. 3.- El profesional de referencia realizará las comunicaciones con otros recursos o sistemas de protección. 4.- Elementos del plan individualizado de intervención social: a.- Análisis global de la situación y por áreas / Valoración de los indicadores de protección y riesgo / Elaboración de un diagnóstico. b.-Objetivos generales y específicos. c.- Actuaciones para la consecución de los objetivos. d.- Categorías profesionales que deben intervenir. e.- Aceptación del plan y compromisos de participación de los usuarios. f.- Método de seguimiento y evaluación de resultados e impacto. 5.- Se articulará con herramientas similares utilizadas en normas sectoriales.
Art. 41. **Historia Social Única.**	1.- Historia Social Única (HSU): instrumento que reúne en un único documento → demanda / registro exhaustivo de datos (personales, familiares, sanitarios, de vivienda, económicos, laborales, educativos) necesarios para la valoración / diagnóstico / plan individualizado de intervención social / acciones realizadas / seguimiento / evolución. 2.- Instrumento técnico básico que permite la relación entre ASP y ASE / Interrelación y coordinación con otros sistemas de protección → Continuidad y complementariedad de las intervenciones. 3.- Soporte digital → Interoperabilidad. 4.- Todas las personas titulares de servicios tendrán una HSU vinculada a la Tarjeta Social y a su código personal.

	5.- Información de la HSU: a.- Datos personales, familiares, sanitarios, de vivienda, económicos, laborales, educativos … b.- Documentos técnicos de análisis, valoración y diagnóstico. c.- Planes individualizados de intervención social d.- Identificación de profesionales de referencia. e.- Actuaciones realizadas y prestaciones percibidas. f.- Seguimiento y evaluación de resultados. 6.- Incluye información sobre actuaciones y medidas de atención efectuadas por otros sistemas públicos. 7.- La HSU se integrará en el SISS.
Art. 42. **Acceso de los profesionales a la HSU.**	1.- El acceso por los profesionales intervinientes a la HSU permitirá la incorporación de la información relativa a todas las actuaciones realizadas / El acceso se realizará conforme a la normativa de protección de datos de carácter personal. 2.- Se garantiza el estricto secreto profesional y el acceso se limita al contenido necesario para la realización de las tareas encomendadas.
Art. 43. **Derecho de acceso de los usuarios a la HSU.**	1.- Los usuarios, directamente o por su representante, tienen derecho de acceso a los documentos y datos de la HSU y a obtener copia de estos. 2.- Si la atención se presta a familias, unidades de convivencia o grupos → derecho de acceso individual. 3.- Menores de edad, personas con apoyo a su capacidad jurídica, personas con orden de protección o medida cautelar → el derecho de acceso lo tendrá la persona titular de la patria potestad, tutela, guarda, curatela o defensor judicial, así como el Ministerio Fiscal. 4.- Se establecerá reglamentariamente el acceso a la información de HSU de personas fallecidas.
Art. 44. **Protección de datos de la HSU.**	1.- El tratamiento de datos personales se regulará por la normativa especial en materia de protección de datos personales, protección de la infancia, protección de personas con discapacidad, de igualdad de género … 2.- Los titulares de los centros directivos son los responsables del tratamiento de los ficheros.
Art. 45. **Conservación de la HSU.**	1.- La conservación de los documentos y datos de la HSU se rige por la normativa de archivos y patrimonio documental. 2.- Las historias sociales que formen parte de un proceso judicial o administrativo se conservarán hasta la resolución definitiva del proceso. 3.- La CM determinará el régimen de responsabilidades de conservación y custodia de la HSU.
Art. 46. Otros documentos.	El SPSS desarrollará los instrumentos comunes de valoración, diagnóstico, atención, evaluación o de otra naturaleza que sean pertinentes.

TÍTULO IV. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES, ORDENACIÓN Y PARTICIPACIÓN.	
Capítulo I. Planificación de los Servicios Sociales.	
Art. 47. **Disposiciones generales.**	1.- El Gobierno de la CM, por medio de la consejería competente, realizará una planificación del SPSS, desde un análisis de las necesidades presentes y una prospección de las necesidades futuras. 2.- Las entidades locales podrán elaborar instrumentos de planificación en su ámbito territorial y competencial, en coordinación con el plan regional. 3.- Planificación del SPSS → Plan Director de SS.SS. / Planes operativos / Planes municipales.
Art. 48. **Plan Director de SS.SS.**	1.- Instrumento de planificación → objetivos, líneas de actuación y resultados esperados del SPSS / Período máximo de 4 años. 2.- Incluye mecanismos de coordinación con otros sistemas de protección, AA.PP. y entidades privadas. 3.- Se apoya en un estudio de los recursos sociales y las necesidades no cubiertas, fórmulas idóneas para atenderlas y cualificación económica, pautas de control de la calidad, plan operativo de seguimiento y evaluación intermedia/final. 4.- Será elaborado por las AA.PP. y entidades del SPSS + organizaciones académicas, sociales, profesionales, sindicales y empresariales. 5.- Aprobado por el Consejo de Gobierno / Propuesto por la Consejería competente. 6.- El Plan incluirá memoria económica. 7.- Se publicará en el Portal de Transparencia de la CM.
Art. 49. **Planes operativos.**	1.- Serán elaborados por los centros directivos de la Consejería → medidas y acciones concretas acordes con el Plan Director. 2.- Los planes operativos integrarán los objetivos establecidos en el Plan Director. 3.- Serán aprobados por el titular de la Consejería / serán propuestos por la dirección de los centros directivos.
Art. 50. **Mapa de SS.SS.**	1.- Instrumento del SPSS que establece su organización territorial y funcional, mediante la configuración de la red de centros y servicios. 2.- Es un mapa/s que refleja/n el despliegue del sistema de SS.SS. en la CM → distribución equilibrada en relación con las variables sociales, demográficas y económicas. 3.- Recogerá la información de las Red de SS.SS. de ASP y ASE / Incluye recursos del SPSS y recursos de naturaleza privada. 4.- Herramienta básica para la elaboración de instrumentos de planificación y determinación de las ratios de cobertura de los recursos. 5.- Será elaborado por la Consejería competente / se actualizará permanentemente. 6.- Se habilitarán instrumentos para facilitar el acceso digital de los usuarios a la información del Mapa de SS.SS.
Capítulo II. Centros y Servicios de Atención Social.	
Art. 51. **Ámbito de aplicación y régimen de prestación.**	1.- La prestación de SS.SS. por las AA.PP. y la iniciativa privada está sometida a los regímenes de comunicación, autorización y acreditación. 2.- El Consejo de Gobierno regulará las condiciones de apertura, funcionamiento y cierre de los centros y servicios.

Art. 52. **Centros de atención social.**	1.- Centros de atención social → unidades orgánicas y funcionales con infraestructura material, singular o compartida, identificables y con funcionamiento autónomo, en las que se realizan prestaciones propias de los SS.SS. - Pueden ser residenciales / no residenciales. 2.- La Cartera de Servicios recogerá: clasificación de los centros / requisitos básicos atendiendo a su función principal y al ámbito de atención. 3.- Son de titularidad pública o privada / contarán con una persona responsable de su dirección, organización, funcionamiento y administración.
Art. 53. **Servicios de atención social.**	1.- Servicios de atención social → prestaciones de carácter general o especializado, realizadas por una entidad de SS.SS. → utilización de medios o acciones, organizados técnica y funcionalmente para cumplir los fines de esta Ley. - Los servicios de atención social no precisan estar vinculados a una infraestructura material. 2.- La Cartera de Servicios mantendrá actualizada la tipología de servicios / sus condiciones / sus requisitos básicos.
Art. 54. **Condiciones materiales y funcionales de centros y servicios.**	1.- Condiciones materiales básicas de los centros y servicios: a.- Cumplimiento de normativa de accesibilidad universal, sanitaria y de seguridad. b.- Adecuación a las actividades de los servicios y adaptación a las condiciones físicas de los usuarios. 2.- Condiciones funcionales básicas de los centros y servicios: a.- Garantías de los derechos de los usuarios. b.- Atención social adecuada. c.- Normas de régimen interno adecuadas a la prestación de los servicios. d.- Régimen de precios. e.- Publicidad de la documentación exigible → información completa y accesible sobre los derechos y deberes del usuario / datos acreditativos del centro y de la entidad. f.- Existencia de personal suficiente, cualificado e idóneo / ratios de personal en función de su cualificación y funciones. g.- Documento de admisión: condiciones de prestación del servicio, firma del usuario y del titular del centro o servicio. h.- Fomento de la autonomía personal de las personas atendidas. i.- Suscripción de pólizas de seguros de responsabilidad que cubran eventuales daños. j.- Sistema de evaluación de calidad del centro o servicio.
Capítulo III. Ordenación de la actividad de los Centros y Servicios de atención social.	
Art. 55. **Disposición general.**	Los servicios, entidades y centros, como garantía de calidad están sujetos al deber de comunicación y a la necesidad de autorización y, en su caso, de acreditación de su actividad.
Art. 56. **Comunicación.**	1.- Comunicación → acto mediante el que una entidad prestadora de servicios sociales, pública o privada, pone en conocimiento de la Administración de la CM el inicio o modificación de un servicio o la modificación de un centro de atención social que no requiera nueva autorización. 2.- Requiere comunicación: a.- El inicio de la actividad de un servicio.

	b.- La modificación de las condiciones autorizadas en centros que no supongan alteraciones sustanciales. c.- La modificación de las condiciones funcionales o materiales que puedan introducirse con posterioridad a la comunicación, salvo que supongan alteraciones sustanciales. d.- El traslado de servicios de atención social. e.- El cambio de titularidad de centros y servicios. f.- El cese, temporal o definitivo, de la actividad de centros y servicios. 3.- Se efectuará a través de la normativa sobre el procedimiento administrativo común. La comunicación permite el inicio de la actividad o del acto comunicado desde el día de su presentación.
Art. 57. **Autorización administrativa.**	1.- Autorización administrativa → acto de la Administración de la CM por el que se reconoce la idoneidad de un centro de atención social de titularidad pública o privada para la prestación de servicios, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos. 2.- Actos sometidos al régimen de autorización administrativa: a.- Creación de centros de atención social. b.- Traslado de centros. c.- Alteración sustancial en la infraestructura material de los centros. d.- Cambios en la identificación inicial en los centros (alteraciones en el tipo, subtipo o ámbito de atención del centro). 3.- Las resoluciones de autorización administrativa se resolverán y notificarán en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de presentación / Si trascurrido el plazo no hay resolución expresa, se entiende desestimada la autorización.
Art. 58. **Documentación y licencia de apertura.**	1.- La solicitud de autorización administrativa y la comunicación se acompañarán de la documentación para acreditar las condiciones materiales y funcionales y de una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos. 2.- Los ayuntamientos establecerán la obligatoriedad de la licencia de apertura.
Art. 59. **Acreditación administrativa.**	1.- Acreditación → Acto mediante el que la Administración de la CM reconoce la capacidad de un centro o servicio de atención social, de titularidad pública o privada, para formar parte del SPSS. - Es un trámite independiente y complementario a los de autorización administrativa y de comunicación. 2.- La acreditación verifica el cumplimiento de los requisitos y estándares de calidad establecidos. 3.- Para concertar o contratar la realización de programas o servicios se podrá requerir la autorización administrativa. 4.- El procedimiento de acreditación se desarrollará reglamentariamente por el Consejo de Gobierno de la CM. - El órgano competente para otorgar la acreditación será la Consejería. - Las resoluciones de acreditación se resolverán y notificarán en un plazo máximo de 4 meses desde la fecha de presentación de la documentación. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se entenderá desestimada.

Art. 60. **Revocación, caducidad e imposibilidad de continuar la actividad.**	1.- La Consejería competente acordará la revocación de la autorización o acreditación administrativa para prestar servicios de atención social o declarará la imposibilidad de continuar con la actividad en los siguientes supuestos: a.- Incumplimiento de las condiciones o desaparición de las circunstancias que motivaron su concesión. b.- Imposición de una sanción administrativa por infracción muy grave, cuando la sanción implique el cierre total o parcial del centro o servicio. c.- Por inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato, declaración o documento o la no presentación cuando exista obligación de hacerlo. 2.- La caducidad de la autorización o acreditación administrativa, y de los efectos de comunicación, se producirá en el plazo de un año.
Capítulo IV. Participación.	
Art. 61. **Principio general.**	Las AAPP promoverán la participación de personas, grupos y entidades sociales, en relación con la elaboración y ejecución de las políticas de SS.SS.
Art. 62. **Participación de los usuarios de centros y servicios.**	1.- Todos los centros y servicios del SPSS contarán con un procedimiento para la participación directa de los usuarios o sus representantes legales y, en su caso, de las familias. 2.- Criterios democráticos para la participación → se podrá extender al funcionamiento del centro y al desarrollo y organización de los servicios o actividades. 3.- En ningún caso este derecho podrá alterar la tipología del recurso, su naturaleza o finalidad, los derechos y deberes de los usuarios …
Art. 63. **Participación ciudadana.**	1.- La participación podrá realizarse a través de entidades o mediante su representación en órganos colegiados. 2.- La CM podrá promover fórmulas de participación, directa e indirecta → foros, encuestas o consultas, presenciales o virtuales. 3.- Promoción de espacios compartidos entre ciudadanos y profesionales.
Art. 64. **Participación institucional.**	La participación institucional y de representación de la sociedad se articulará mediante órganos colegiados de carácter consultivo.
Art. 65. **Consejo de SS.SS. de la CM.**	1.- Consejo de SS.SS. de la CM / adscrito a la Consejería competente → máximo órgano de carácter consultivo y de participación en materia de SS.SS. 2.- En el Consejo de SS.SS. estarán representados: a.- La Comunidad de Madrid. b.- Las entidades locales. c.- Las entidades del tercer sector. d.- Las asociaciones de usuarios. e.- Los colegios profesionales. f.- Las universidades e instituciones académicas. g.- Organizaciones sindicales y empresariales. 3.- Funciones del Consejo de SS.SS.: a.- Recibir información de la acción y resultados del SPSS. b.- Realizar seguimiento sobre la ejecución de los planes.

	c.- Emitir recomendaciones para la mejora del SPSS. d.- Informar los proyectos y anteproyectos normativos e instrumentos de planificación. e.- Deliberar sobre cuestiones y aportar sugerencias, propuestas e iniciativas. f.- Promover una perspectiva ética en la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas sociales.
Art. 66. **Consejos Locales de SS.SS.**	Las entidades locales podrán constituir órganos de participación en su respectivo ámbito territorial.
Art. 67. **Impulso del voluntariado.**	1.- La CM promoverá y apoyará la práctica del voluntariado → participación ciudadana, solidaridad y compromiso con el bienestar y mejora de la calidad de vida del conjunto de la población. 2.- La acción voluntaria podrá actuar de forma complementaria al SPSS y otros sistemas de protección de la CM / En ningún caso implicará relaciones laborales o mercantiles / Será siempre complementario a la atención profesional a la que no podrá sustituir.

TÍTULO V. PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES.	
Capítulo I. Formas de provisión.	
Art. 68. **Disposición general.**	Las AA.PP. integradas en el SPSS podrán prestar SS.SS. directamente o a través de fórmulas de gestión indirecta.
Art. 69. **Gestión directa de las AA.PP.**	1.- Servicios públicos de gestión directa → Servicios prestados por las AA.PP. mediante recursos profesionales y financieros propios, sean de ASP o de ASE. 2.- Actuaciones que suponen el ejercicio de autoridad sobre las entidades prestadoras de SS.SS. → Los servicios de inspección, control de calidad, autorización, acreditación y Registro de Entidades, Centros y Servicios se llevarán a cabo mediante gestión directa por las AAPP.
Art. 70. **Gestión indirecta de los SS.SS.**	1.- La realización de prestaciones de SS.SS. en funciones no reservadas al ejercicio directo de las AA.PP. podrá efectuarse mediante los instrumentos jurídicos adecuados a cada caso. 2.- Las entidades privadas podrán contratar o concertar con las AA.PP la prestación de servicios. 3.- Las entidades de iniciativa privada que participen en la gestión indirecta de los SS.SS. estarán sujetas a inspección y control de calidad de su actividad.
Art. 71. **Prestación de SS.SS. por entidades privadas.**	1.- La actividad privada puede corresponder a personas físicas o jurídicas, sin ánimo de lucro o de carácter mercantil, que cumplan los requisitos establecidos. 2.- No podrá realizarse prestación de SS.SS. sin estar en posesión de la previa autorización administrativa o haber realizado la comunicación preceptiva. 3.- Las bases reguladoras de las subvenciones establecerán las condiciones para lograr una coordinación efectiva con la actuación del SPSS.
Capítulo II. Concierto Social.	
Art. 72. **Régimen de concertación en el SPSS.**	1.- Concierto social → instrumento no contractual que permiten la realización total o parcial de programas sociales, así como la provisión de prestaciones en el marco del SPSS, por entidades privadas. 2.- El Consejo de Gobierno desarrollará reglamentariamente el régimen jurídico de la colaboración y condiciones de prestación de centros y servicios (procedimiento de suscripción, duración de los conciertos, obligaciones de las partes …). 3.- Los conciertos sociales formalizados serán inscritos en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Atención Social.
Art. 73. **Principios de la concertación.**	1.- Los acuerdos de acción concertada requieren la evaluación y determinación previa de necesidades → Cumplirán los principios de subsidiariedad e igualdad en la atención a los usuarios. 2.- Otros principios → Libertad de acceso, publicidad y transparencia de los procedimientos y asignación eficiente de los recursos públicos.
Art. 74. **Objeto del concierto social.**	1.- Pueden ser objeto de concertación por parte de las AA.PP.: a.- Las reservas de plazas en centros o servicios para su ocupación por usuarios del SPSS. b.- La gestión integral de programas, servicios, prestaciones o centros. 2.- Se podrá efectuar una concertación conjunta con una pluralidad de entidades.

Art. 75. **Requisitos para la suscripción de conciertos.**	Podrán suscribir conciertos las personas físicas o jurídicas de carácter privado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.
Art. 76. **Financiación del régimen de concierto.**	1.- La cuantía de los fondos para los servicios concertados se recogerá en los presupuestos de las AA.PP. correspondientes. 2.- Se establecerán anualmente los módulos económicos correspondientes. 3.- Los módulos económicos retribuirán los costes fijos y variables de las prestaciones, así como los costes indirectos en que se pueda incurrir. 4.- Se podrá establecer un precio o modulo económico por plaza ocupada y un porcentaje inferior por plazas concertadas no ocupadas.

TÍTULO VI. CALIDAD, TRANSPARENCIA, INSPECCIÓN Y FORMACIÓN.	
Capítulo I. Calidad, evaluación y transparencia de los Servicios Sociales.	
Sección 1ª. Calidad y evaluación.	
Art. 77. **Calidad de los SS.SS.**	1.- Las AA.PP. promoverán la mejora de la calidad del SPSS y, en especial, la cualificación y formación de los empleados públicos, así como la investigación. 2.- La Cartera de Servicios definirá los criterios y estándares mínimos de calidad exigibles a todas las prestaciones, con independencia de la entidad prestadora → Criterios sobre recursos materiales y equipamientos, recursos humanos, procesos de gestión y resultados en las personas -tanto beneficiarias como profesionales-. 3.- Las evaluaciones de calidad se coordinarán con las que realice la unidad administrativa. 4.- La CM garantizará el cumplimiento de los niveles de calidad a través de la evaluación continua, el análisis de datos, las funciones de inspección y control o la aplicación del régimen sancionador.
Art. 78. **Objetivos de la calidad en los SS.SS.**	1.- La Consejería, en colaboración con las entidades locales, promoverá la mejora permanente de la calidad de los servicios → Objetivos de la calidad: a.- Fomentar la perspectiva de la calidad y el desarrollo concreto de pautas de acción. b.- Desarrollar procesos de atención integrales apoyados en las evidencias de investigación y evaluación. c.- Incorporar la formación, auditorías de calidad y certificación en la programación de las unidades, centros y servicios del SPSS. d.- Ofrecer información pública, transparente y actualizada relativa a los indicadores de calidad. 2.- La Consejería competente elaborará un plan de calidad de los SS.SS. (alineado con el Plan Director) → Contenidos del Plan de Calidad: a.- Determinación de los objetivos específicos de calidad, indicadores y metodología de evaluación. b.- Requisitos de calidad exigibles a las prestaciones sociales. c.- Instrumentos y métodos de mejora. d.- Análisis de la información obtenida en procedimientos de participación. e.- Pautas para la realización de estudios de opinión y procedimientos de participación. f.- Directrices para la formación de los profesionales. g.- Procedimientos relativos a la formulación de sugerencias, quejas y reclamaciones.
Art. 79. **Calidad en la práctica profesional.**	1.- Los profesionales de los SS.SS. deben reunir requisitos de titulación específica. 2.- Modelo de gestión de competencias profesionales → desempeño eficaz y adecuado a los objetivos de calidad.
Art. 80. **Evaluación en el SPSS.**	1.- Finalidad de la evaluación del SPSS: a.- Evidencias de la eficacia de las políticas sociales, planes, programas y proyectos. b.- Información sobre el funcionamiento, calidad y adecuación de las prestaciones, centros y servicios → ajuste y mejora continua. c.- Información para el diseño y orientación de las políticas sociales y de programas y proyectos, a partir de las iniciativas de participación.

	2.- La Cartera de Servicios definirá los métodos de evaluación y los indicadores pertinentes. 3.- La CM requerirá la implantación de sistemas de evaluación de la calidad en los centros y servicios.
Sección 2ª. Transparencia.	
Art. 81. **Transparencia.**	1.- Las AA.PP. del SPSS y las entidades privadas -con o sin ánimo de lucro- están sujetas a las obligaciones legales en materia de transparencia y de publicidad de la información. 2.- La información se proporcionará en formatos abiertos y reutilizables.
Capítulo II. Función inspectora.	
Art. 82. **Objeto de la actuación inspectora.**	Objeto de la actuación inspectora de la CM → Control, vigilancia, comprobación y orientación sobre el cumplimiento de la normativa / supervisión del funcionamiento / aseguramiento de la calidad exigida de los servicios.
Art. 83. **Personal inspector.**	1.- La Consejería competente acreditará al personal inspector / La labor inspectora será efectuada por funcionarios públicos / Se tendrán en cuenta criterios de experiencia y conocimiento en SS.SS. 2.- La plantilla deberá tener una dimensión suficiente / adecuación / calidad. 3.- El personal inspector deberá acreditar su condición y será considerado como agente de autoridad. 4.- Desempeñará sus funciones con plena independencia y podrá recabar la cooperación de otras instituciones. 5.- Secreto y sigilo profesional / Actuación desde los principios de objetividad, transparencia e imparcialidad.
Art. 84. **Actuaciones inspectoras.**	1.- Todos los centros y servicios serán inspeccionados periódicamente con arreglo a un plan de inspección / Los centros residenciales y de atención diurna serán inspeccionados al menos una vez al año. 2.- Se realizará inspección siempre que se produzca una reclamación o se tenga conocimiento de una deficiencia o actuación irregular (conductas que puedan ser calificadas como grave o muy grave). 3.- El personal inspector podrá: a.- Acceder libremente sin aviso o notificación previa a centros. Si son domicilios debe pedir el previo consentimiento de sus titulares. b.- Acceder a los datos de actividad de los centros. c.- Efectuar las comprobaciones necesarias y pertinentes. d.- Acceder a la documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones, así como a la información o documentación que se estime necesaria. e.- Acceder a los expedientes de los usuarios, para verificar la adecuación de las prestaciones y servicios. f.- Entrevistar a usuarios, representantes y familiares. g.- Visitar el domicilio de las personas beneficiarias para verificar la calidad de la asistencia, así como la persistencia de los requisitos y condiciones necesarias para el acceso a las mismas. 4.- El personal inspector podrá requerir, motivadamente, la comparecencia de los interesados.

	5.- Las entidades titulares, sus representantes y el personal responsable están obligados a facilitar a la inspección el acceso a las instalaciones y sistemas de información, documentos y datos preceptivos, interlocución con los usuarios y suministrar toda la información necesaria. 6.- Se considera obstrucción a la acción inspectora cualquier acción u omisión que dificulte o impida su ejercicio. 7.- En las actas deberá constar: a.- Fecha, hora y lugar de inspección. b.- Identificación del personal inspector. c.- Identificación de la entidad prestadora y de la persona responsable. d.- Hechos y circunstancias relevantes apreciadas en la inspección. e.- Manifestaciones del personal compareciente. f.- Advertencias, recomendaciones o requerimientos de la parte inspectora. g.- Firma de la parte inspectora y manifestación de la conformidad o disconformidad. 8.- Se entregará copia del acta, a la persona ante la que se realice (notificación). 9.- Las actas se consideran prueba de los hechos constatados. 10.- Las actas tendrán carácter probatorio en el procedimiento sancionador.
Art. 85. **Propuesta de adopción de medidas provisionales.**	1.- Si se identifican riesgos para la integridad física o psíquica u otras situaciones de urgencia → el personal inspector podrá, de forma motivada, proponer la adopción de medidas provisionales / Si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal se podrán en conocimiento del Ministerio Fiscal o de los órganos judiciales competentes.
Capítulo III. Innovación y formación en Servicios Sociales.	
Art. 86. **Programas de investigación, desarrollo e innovación.**	1.- La CM impulsará la investigación aplicada para la orientación eficiente de las políticas públicas. 2.- Programas de investigación, desarrollo e innovación o investigaciones con otras CC.AA. o en el ámbito nacional o internacional / Participación de instituciones académicas, entidades públicas y privadas, profesionales … 3.- Fórmulas de colaboración con entidades públicas y privadas → proyectos de ámbito interregional, estatal, europeo o internacional. 4.- La CM podrá establecer su grado de participación en los derechos de los programas de investigación e innovación en que colabore.
Art. 87. **Formación.**	La Consejería competente promoverá formación especializada, inicial y continua del conjunto de profesionales del SPSS.

TÍTULO VII. FINANCIACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.	
Art. 88. **Principios de financiación.**	Habilitación de créditos en los presupuestos de las AA.PP. para proveer los recursos necesarios para asegurar la dotación suficiente de las prestaciones del SPSS de acuerdo con los niveles de calidad establecidos.
Art. 89. **Recursos generales del SPSS.**	Recursos de financiación general del SPSS: a.- Créditos de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. b.- Créditos de los presupuestos de las entidades locales. c.- Créditos procedentes de la Administración General del Estado (Dependencia), d.- Recursos procedentes de organismos supranacionales. e.- Recursos de carácter extraordinario de las AA. autonómica y locales. f.- Subvenciones, donaciones, herencias, legados … g.- Recursos aportados por entidades públicas o privadas en inversiones de impacto social, mecenazgo … h.- Aportaciones de usuarios de centros y servicios.
Art. 90. **Financiación por la CM.**	1.- El Presupuesto de la CM incluye los créditos para programas de SS.SS. de ASE + Prestaciones económicas. 2.- Participa en la financiación de la red de ASP. 3.- La CM primará la financiación de la mancomunidad de SS.SS. constituidas por municipios de población inferior a 20.000 habitantes. 4.- Los municipios de menos de 20.000 habitantes no mancomunados deberán prestar los servicios en las condiciones de calidad establecidas. 5.- Los municipios desvinculados de una mancomunidad no supone la garantía de la misma financiación. 6.- Se podrán poner en marcha fórmulas de colaboración y coordinación para garantizar la coordinación y responsabilidad compartida. 7.- La CM impulsará iniciativas singulares y proyectos piloto de ámbito limitado. 8.- La atribución de competencias autonómicas a las entidades locales implicar la transferencia de los medios materiales, personales y económicos.
Art. 91. **Aportaciones de los usuarios y régimen de precios.**	1.- Las AA.PP. podrán establecer la participación económica de los usuarios en el coste de las prestaciones de servicios. 2.- Para la determinación de las cuantías se tendrá en cuenta la naturaleza de los servicios, su coste, el grupo de población al que se dirigen y si capacidad económica y patrimonial → Principios de equidad, proporcionalidad, progresividad, redistribución y universalidad. 3.- La capacidad económica de los usuarios no limitará ni supondrá obstáculo para el acceso al SPSS. 4.- Podrán establecerse modalidades alternativas de pago cuando no puedan asumirse de forma pecuniaria. 5.- Los precios de plazas de centros y servicios financiadas en exclusiva por otras AA.PP. se regirán por sus normas / La CM puede establecer precios de referencia. 6.- Los precios de plazas de centros y servicios de titularidad privada están sujetos a comunicación a la consejería competente en materia de consumo. 7.- La prestación de servicio público por estancia o atención en centro de atención social para personas con discapacidad será gratuita / También para los menores de edad en el sistema de protección o de ejecución de medidas judiciales.

Art. 92. **Otras contribuciones de personas o entidades.**	1.- Las personas físicas y jurídicas ajenas al SPSS pueden participar en la realización y financiación de actividades, encuadradas en las líneas de actuación del Plan Director de SS.SS., mediante la celebración de convenios, incluido el mecenazgo. 2.- Mecenazgo → participación de personas físicas o jurídicas en la financiación del SPSS mediante la aportación de fondos o la entrega o cesión de bienes. 3.- Las aportaciones de mecenazgo pueden ser en metálico o en especie, mediante la entrega de bienes o la prestación de servicios. 4.- Por vía reglamentaria se podrán establecer procedimientos específicos de colaboración. 5.- Las personas físicas o jurídicas tendrán derecho a la visibilidad de su nombre o imagen.

TÍTULO VIII. RÉGIMEN SANCIONADOR.	
Capítulo I. Infracciones.	
Sección 1ª. Disposiciones generales.	
Art. 93. **Infracciones en materia de SS.SS.**	1.- Infracciones administrativas: acciones u omisiones tipificadas en esta ley. 2.- Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, de acuerdo con la obligación infringida y el derecho afectado.
Art. 94. **Sujetos responsables.**	1.- Responsables de las infracciones administrativas en SS.SS.: a.- Personas físicas o jurídicas titulares, gestores, directores y administradores de centros y servicios, cuando concurra dolo o culpa. b.- Personas físicas o jurídicas que realicen actos fraudulentos o utilicen personas físicas o jurídicas interpuestas para conseguir resultados contrarios a lo establecido en la Ley. c.- Titulares responsables directos de sus actos y subsidiarios de las infracciones cometidas por cualquier persona en el centro o servicio. d.- Infracciones cometidas por profesionales de los centros o servicios. 2.- Los usuarios de centros y servicios y los beneficiarios de las prestaciones. 3.- Las personas que realicen conductas de colaboración necesaria o encubrimiento de infracciones realizadas por sujetos responsables.
Art. 95. **Prescripción de las infracciones.**	1.- Prescripción de las infracciones: - Infracciones leves → 1 año. - Infracciones graves → 3 años. - Infracciones muy graves → 5 años. 2.- El plazo se inicia desde el día de la comisión de la infracción / Si es una infracción continuada, comienza cuando haya finalizado la conducta infractora.
Sección 2ª. Infracciones en el ejercicio de la actividad de Centros y Servicios de Atención Social.	
Art. 96. **Infracciones leves.**	Infracción leve → Incumplimiento, por acción u omisión, de los requisitos establecidos, así como de los estándares de calidad, que no constituyan infracción grave o muy grave y no generen riesgo para la seguridad o salud de los usuarios.
Art. 97. **Infracciones graves.**	Infracciones graves: a.- Incumplir, por acción u omisión, los requisitos establecidos cuando produzca consecuencias para la integridad de los usuarios o profesionales de los centros o servicios, o para su patrimonio. b.- Descuidar el deber de asistencia o no facilitar la atención de las necesidades básicas de los usuarios, así como las medidas de vigilancia o cuidado especial, e imponer un horario inadecuado. c.- No mantener el expediente de cada persona usuaria o los sistemas de información de incidencias debidamente actualizados. d.- No suscribir con los usuarios la relación contractual. e.- Permitir o mantener el exceso de ocupación. f.- No disponer de personal suficiente, así como con la titulación oficial o cualificación exigida.

	g.- No tener el establecimiento en las condiciones debidas de mantenimiento, higiene, confort o salubridad. h.- Iniciar o modificar actividades con omisión del deber de comunicación previa. i.- Incumplir el deber de secreto profesional y confidencialidad con respecto a datos de los usuarios. j.- No preservar el derecho a la intimidad de los usuarios. k.- Incumplir la normativa aplicable al centro o servicio. l.- Incumplir las obligaciones relativas a la información y documentación que debe presentarse. m.- No custodiar y administrar con la debida transparencia los bienes de los usuarios de centros o servicios. n.- Realizar ofertas o publicidad de centros o servicios que no se correspondan con los prestados efectivamente. ñ.- No aportar información y documentación veraz y completa para tramitar la autorización, acreditación o el Registro de entidades, centros y servicios. o.- Obstruir o dificultar la acción del personal inspector. p.- Restringir los derechos de los usuarios, así como su libertad de ingreso, permanencia y salida de los centros. q.- Realizar actos que alteren o perturben el normal funcionamiento del centro o servicio o sus condiciones de habitabilidad. r.- Omitir el deber de facilitar información, faltar al respeto, establecer castigos o limitaciones de derechos injustos o amenazar con llevarlos a cabo como represalia o presión al personal, usuarios o sus familiares o acompañantes. s.- Carecer de lista actualizada de precios o cobrar a los usuarios de centros o servicios cantidades superiores a los que corresponda. t.- Reincidir en la comisión de infracciones leves (segunda infracción de la misma naturaleza en el término de un año).
Art. 98. **Infracciones muy graves.**	Infracciones muy graves: a.- Acciones y omisiones leves o graves cuando causen daños permanentes para la integridad física o psíquica de los usuarios. b.- Incumplimiento de las medidas provisionales. c.- Vulnerar los derechos de los usuarios de centros y servicios y no respetar la confidencialidad de sus datos. d.- Realizar actividades en centros o servicios de atención social al margen de la normativa reguladora, de la autorización y acreditación. e.- Impedir con violencia o intimidación la acción inspectora. f.- Agredir física o verbalmente por parte del personal a usuarios, familiares o acompañantes o al personal inspector. g.- Reincidir en la comisión de infracciones graves (comisión de una segunda infracción de la misma naturaleza en el término de un año).
Sección 3ª. Infracciones de los usuarios de centros y servicios y beneficiarios de las prestaciones.	
Art. 99. **Infracciones leves.**	Infracciones leves: a.- No facilitar los datos o documentos requeridos que sean legalmente exigibles. b.- No comparecer de manera injustificada en la fecha fijada ante el órgano gestor de la prestación.

	c.- Mostrar falta de consideración y de respeto hacia el personal del centro o servicio o a otros usuarios o visitantes. d.- Incumplir el reglamento de funcionamiento del centro (si no es falta grave o muy grave).
Art. 100. **Infracciones graves.**	Infracciones graves: a.- Falsear datos, si la falsedad no ha sido determinante para acceder a la prestación. b.- No comunicar cambios o alteraciones de las circunstancias o requisitos. c.- Producir daños a las instalaciones. d.- Alterar gravemente la convivencia. e.- Poner en concreto peligro al personal del centro o servicio o a los demás usuarios o visitantes.
Art. 101. **Infracciones muy graves.**	Infracciones muy graves: a.- Reincidir en la comisión de infracciones graves (comisión de una segunda infracción de la misma naturaleza en el término de un año). b.- Falsear datos a la Administración, si ha sido determinante para su acceso. c,- Cometer agresión física o sexual al personal del centro o servicio, o a los demás usuarios o visitantes.
Capítulo II. Sanciones.	
Sección 1ª. Sanciones en el ejercicio de la actividad de centros y servicios y a los usuarios de centros y servicios y a los beneficiarios de las prestaciones.	
Art. 102. **Sanciones en el ejercicio de la actividad de centros y servicios.**	1.- Tipificación de las sanciones en el ejercicio de la actividad de centros y servicios: - Infracciones leves → apercibimiento escrito o multa de hasta 10.000 euros. - Infracciones graves → multa desde 10.001 euros hasta 100.000 euros. - Infracciones muy graves → . Multa desde 100.001 euros hasta 1.000.000. . Inhabilitación para ejercer como director, gestor o administrador durante los 5 años siguientes. . Prohibición para el ejercicio de actividades sociales, directa o indirectamente. 2.- La imposición de la sanción debe garantizar que la comisión de la infracción no es más beneficiosa que el cumplimiento de las normas infringidas. 3.- Sanciones accesorias en infracciones muy graves: a.- Prohibición del ejercicio de actividades por un plazo de entre 1 y 10 años → revocación de las autorizaciones administrativas. b.- Prohibición de financiación pública entre 1 y 5 años. c.- Cierre definitivo total o parcial del centro o servicio → revocación de la autorización o acreditación administrativa y de los efectos de las comunicaciones.
Art. 103. **Sanciones a usuarios de centros y servicios y beneficiarios de las prestaciones.**	1.- Tipificación de las sanciones cometidas por usuarios: - Infracciones leves → amonestación o multa de 100 a 300 euros. - Infracciones graves → suspensión de la condición de usuario / traslado temporal a otro centro por un período máximo de 12 meses. - Infracciones muy graves → . Extinción de la prestación económica o reintegro.

	. Suspensión del servicio entre 1 y 5 años. . Traslado definitivo a otro centro. . Expulsión del centro.
Sección 2ª. Disposiciones comunes.	
Art. 104. **Criterios de graduación de las sanciones.**	Criterios de graduación para la imposición de las sanciones: a.- Gravedad de la infracción. b.- Existencia de intencionalidad. c.- Gravedad del riesgo o efectos para la salud e integridad de los usuarios. d.- Número de personas afectadas. e.- Continuidad o persistencia en la conducta infractora. f.- Lucro obtenido. g.- Inobservancia de las advertencias, recomendaciones o requerimientos formulados por el personal inspector. h.- Reparación de los daños causados, o colaboración en dicha reparación.
Art. 105. **Enriquecimiento injusto.**	1.- El tercero que hubiera obtenido enriquecimiento injusto tiene el deber de restitución frente a la Administración. 2.- La persona o entidad infractora será responsable solidario de la restitución del importe equivalente al enriquecimiento producido.
Art. 106. **Publicidad de la sanción.**	Se podrá acordar por razones de ejemplaridad la publicidad de las sanciones impuestas, una vez firmes en vía administrativa → publicación del nombre de las personas físicas o jurídicas responsables y de las infracciones cometidas en el Portal de Transparencia y en los medios de comunicación → Prevenir conductas infractoras similares.
Art. 107. **Actualización de las sanciones.**	La actualización de la cuantía de las sanciones se realizará mediante norma reglamentaria del Consejo de Gobierno.
Capítulo III. Régimen sancionador.	
Art. 108. **Procedimiento.**	1.- La imposición de sanciones administrativas requerirá la instrucción de un procedimiento. 2.- Inicio del procedimiento sancionador → competencias: a.- Infracciones en la actividad de centros y servicios → centro directivo competente en materia de ordenación de centros y servicios. b.- Infracciones de los usuarios y beneficiarios de prestaciones → centro directivo competente en la materia. 3,- Instrucción → personal funcionario de la consejería. 4.- Resolución del procedimiento sancionador: . Titular de la consejería. . Cierre definitivo total o parcial del centro → Consejo de Gobierno de la CM. 5.- La apertura de un procedimiento sancionador no será obstáculo para la exigencia de responsabilidades de otro orden. 6.- Plazo para resolver y notificar los procedimientos sancionadores: 1 año.

	7.- Transcurrido el plazo sin que se haya producido la resolución → Caducidad del procedimiento. 8.- Si son infracciones cometidas por los usuarios de centros municipales o prestaciones locales → la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores se pueden delegar a las entidades locales.
Art. 109. **Concurrencia de infracciones y delitos.**	1.- Si los hechos pueden ser constitutivos de delito → el órgano instructor informará al M. Fiscal o al órgano jurisdiccional competente / Si se esta sustanciando un proceso penal → se suspende la iniciación del procedimiento sancionador hasta que recaiga resolución judicial firme. 2.- Si no hay delito / si hay delito compatible con la infracción administrativa → se continúa con el procedimiento sancionador.
Art. 110. **Medidas provisionales en el procedimiento sancionador.**	1.- El órgano competente para iniciar el procedimiento, con anterioridad a la apertura, puede tomar medidas provisionales urgentes y precisas / Deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación (15 días siguientes). 2.- Una vez iniciado el procedimiento sancionador se pueden tomar medidas provisionales de acuerdo a los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. 3.- Derecho a formular alegaciones y presentar documentación. 4.- Podrán acordarse también las medidas provisionales previstas en el procedimiento administrativo común. 5.- Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento sancionador. En todo caso se extinguirán con la resolución administrativa.
Art. 111. **Pago voluntario y reducción de la sanción.**	Pago voluntario de las sanciones pecuniarias → minoración de la cuantía.
Art. 112. **Ejecución forzosa.**	1.- El importe de multas y de responsabilidades administrativas puede ser exigido por vía de apremio. 2.- Se pueden imponer multas coercitivas en los siguientes supuestos: a.- Actos personalísimos en los que no proceda la compulsión directa sobre la persona obligada. b.- Actos en los que no se considera conveniente la compulsión. c.- Actos cuya ejecución la persona obligada pueda encomendar a otra. 3.- La cuantía podrá ser incrementada en un 20% en su cuantía máxima. 4.- La multa coercitiva es independiente de las sanciones y compatible con ellas.
Art. 113. **Destino del importe de las sanciones.**	Los ingresos provenientes de las sanciones se destinarán a la mejora de la calidad y la cobertura del sistema de SS.SS.